RÉSEAU PÉRINAT DE YAOUNDÉ (RPY): UNE APPROCHE POUR AMÉLIORER LA SANTÉ MATERNELLE ET NÉONATALE

7ÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE REMEHBS 23-25 JUILLET 2025
BOBO-DIOULASSO / BURKINA FASO

Dr Clémence VOUGMO

PEDIATRE NEONATOLOGISTE

MEDECIN DE SANTE PUBLIQUE

ADMINISTRATRICE DU RESEAU PERINAT DE YAOUNDE

MINSANTE CAMEROUN

PLAN

I-INTRODUCTION

II-RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DOUALA

III-PERSPECTIVES

IV-CONCLUSION

I-INTRODUCTION

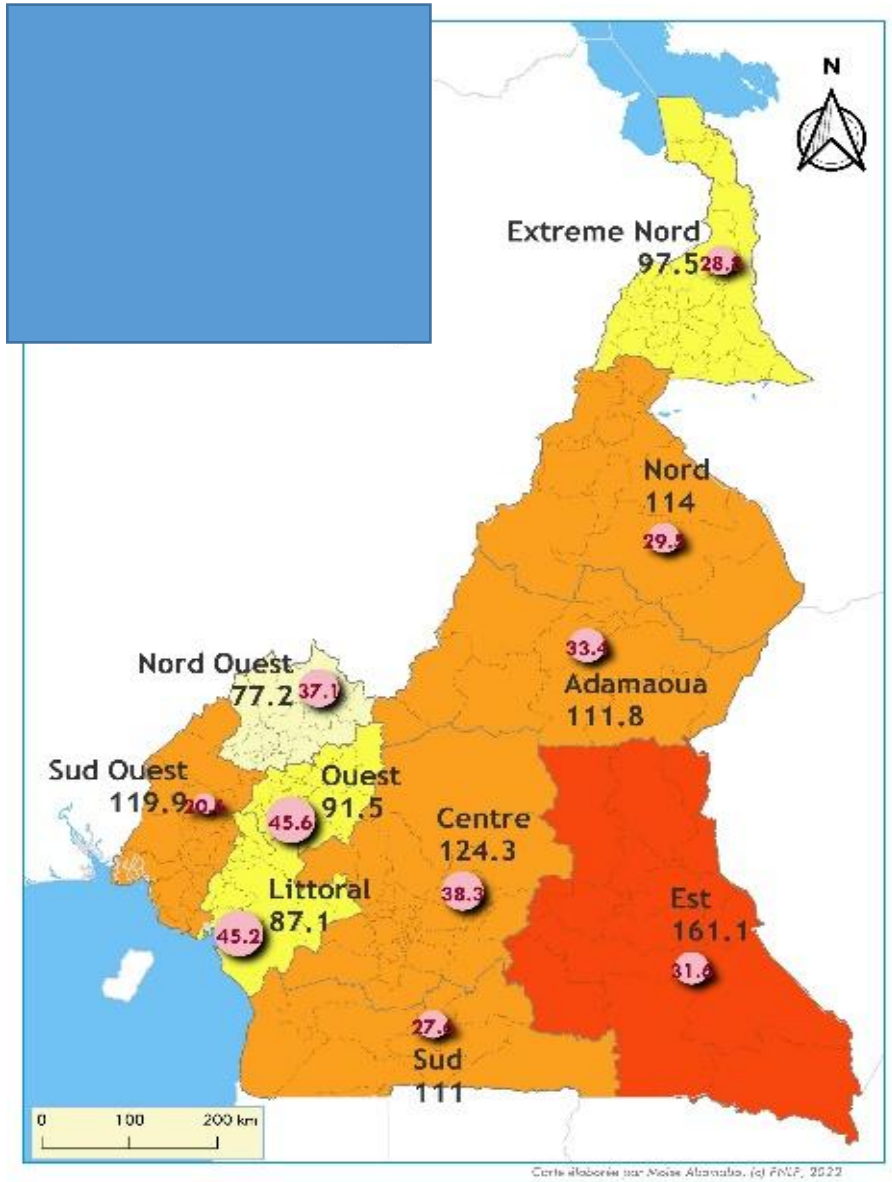
CAMEROUN

Pays de l’Afrique Centrale

Superficie : 475 442 km2

Population totale :30 135 732 hab

Densité : 63 hab/km2



I-INTRODUCTION

- Santé maternelle : problème dé santé publique

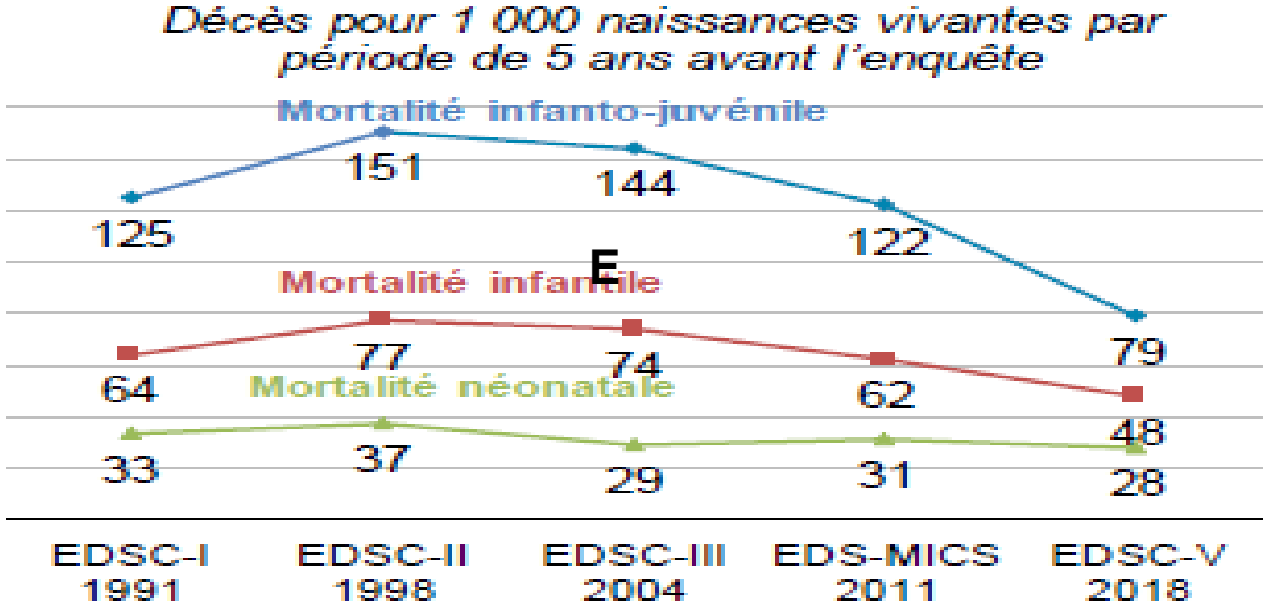
Progression énorme : 732 décès / 100 000 NV en 2011 à 406 en 2018**)**
(EDSC 2018)

Réduction de la mortalité maternelle de plus de 48%

- Santé du nouveau-né : stagnante depuis 3 décennies

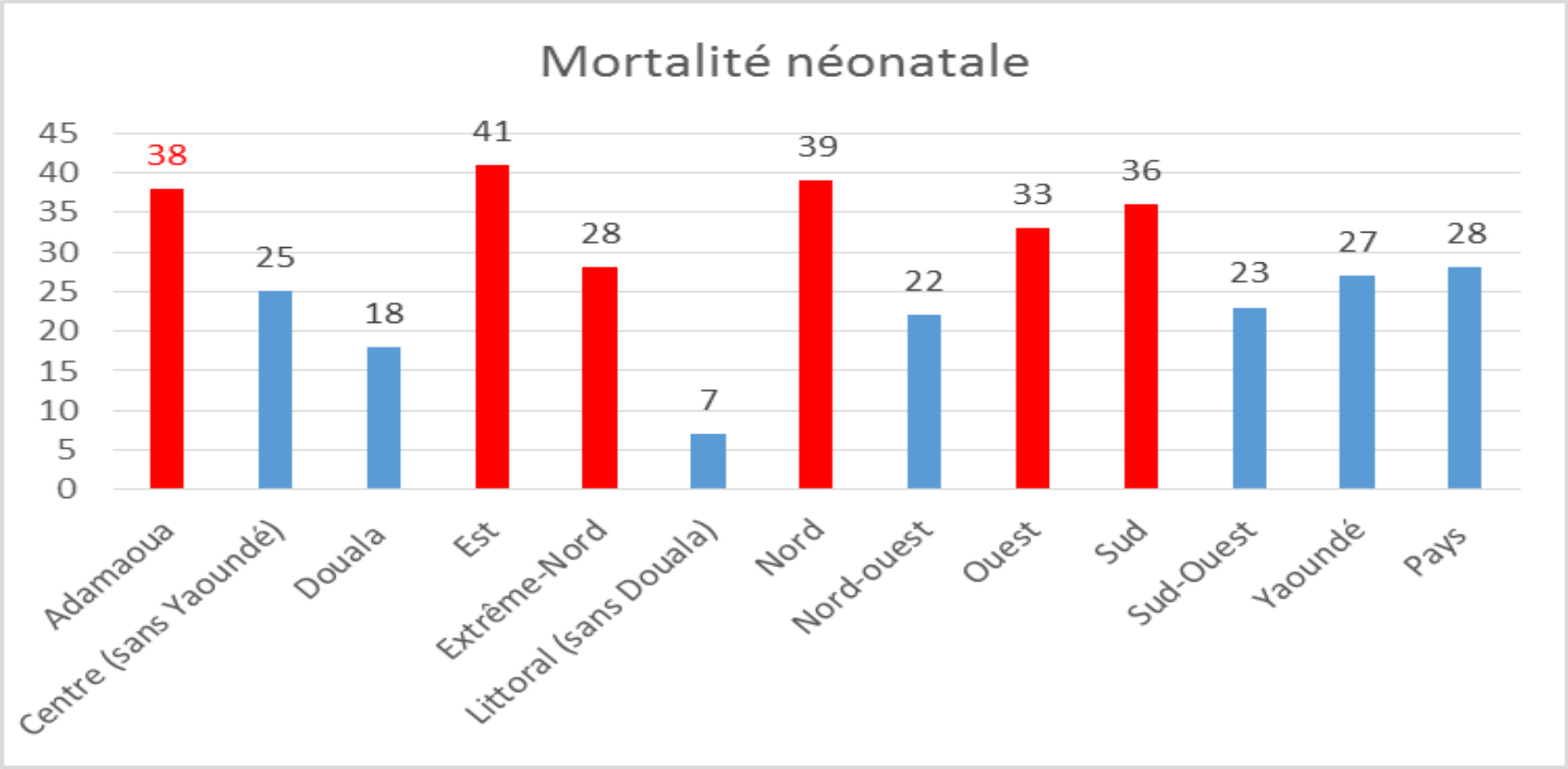
I-INTRODUCTION

Graphique 4 **Tendances de la mortalité des enfants de moins de 5 ans**



Stagnation du nombre de décès des nouveau-nés depuis plus d'une dizaine d'années au Cameroun /Taux de décès néonatals 28‰ en 2018 (EDSC 2018)

I-INTRODUCTION

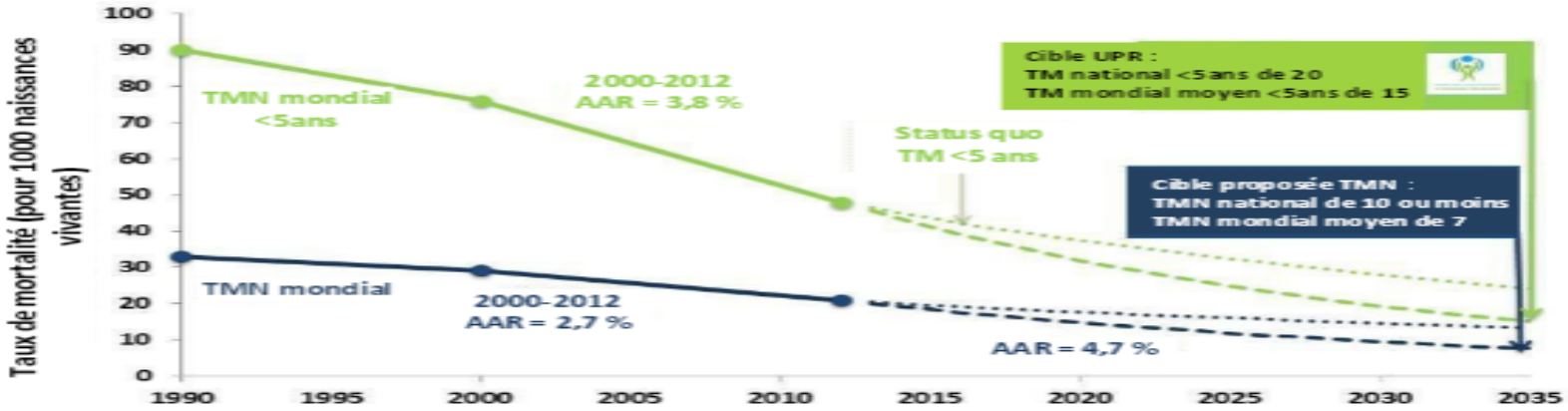


I-INTRODUCTION

Plusieurs pays n’atteindront probablement pas la cible fixée dans les ODD en matière de mortalité néonatale d’ici 2030 (OMS, Mars 2024): 12 décès pour 1000 NV

Figure 3 : Trajectoire de la mortalité des moins de cinq ans et de la mortalité néonatale d’ici à 2035

Cible proposée pour le taux de mortalité néonatale d’ici à 2035
Liée à la cible de « Une promesse renouvelée » pour les décès évitables chez les enfants



Scénario	Décès néonatals 2035	TMN mondial 2035 (pondéré)
Statu quo	1,8 millions	13
Tous les pays atteignent un TMN de 10 pour 1000	1 million	7
	Suppose réduction du TMN >2/3 pour tous les pays, comme en prolongement de l’OMD4	

Sources des données : Trajectoire calculée sur la base des taux de mortalité fournis par le Groupe interorganisations des Nations Unies pour l’estimation de la mortalité infantile, Niveaux et tendances en matière de mortalité infantile : Rapport 2013

I-INTRODUCTION

CAUSES DES DÉCÈS NÉONATALS ÉVITABLES

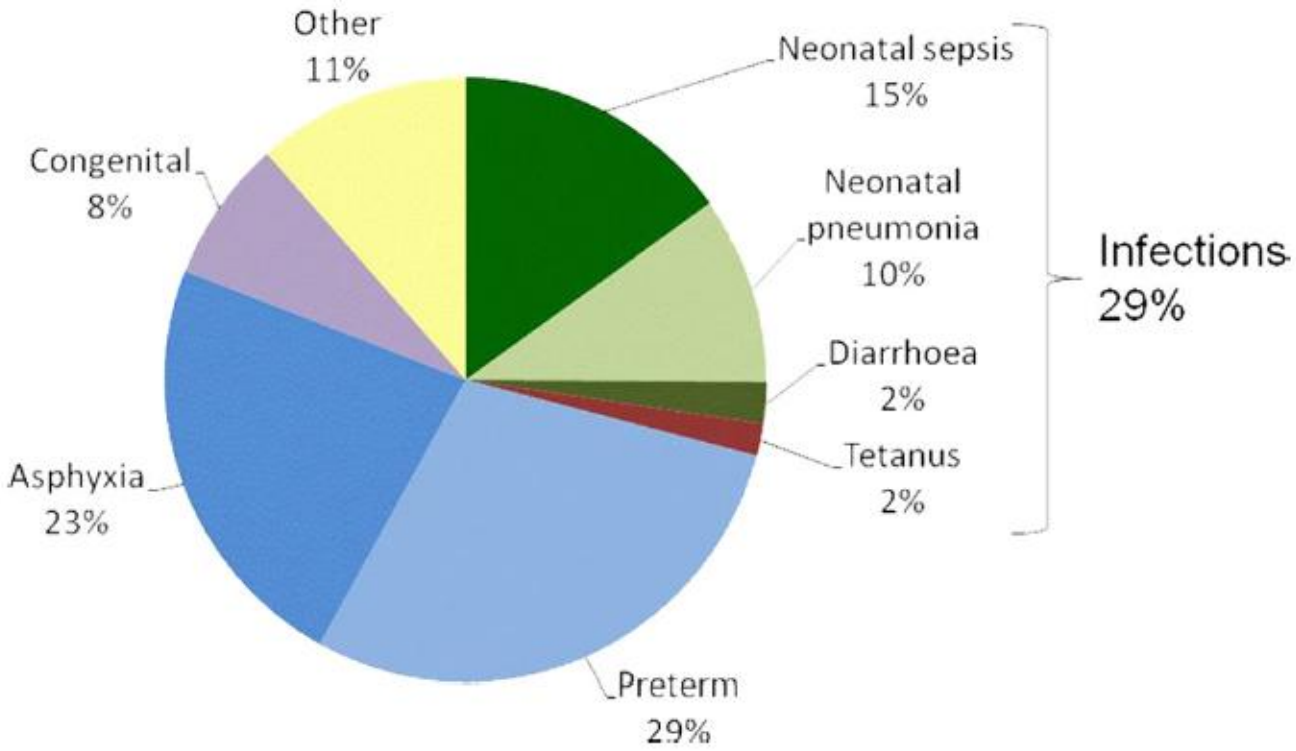


Figure 4 Causes of neonatal death for 3.6 million neonatal deaths, for 192 countries based on cause-specific mortality data and multicause modeled estimates. (Data source: Based on data from Child Health Epidemiology Reference Group and WHO in Black et al.[3]) (Color version of figure is available online.)

II-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DOUALA

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Yaoundé et Douala : 1ère et 2ème plus grandes agglomérations du Cameroun

Constat avant la création des deux RP :

parents de nouveau-nés nécessitant des soins plus complexes:

livrés à eux-mêmes pour trouver une FOSA capable de fournir les soins nécessaires et accepter de prendre le nouveau-né en charge .

Conséquence : Cette recherche erratique de soins adaptés, parfois sur de longues distances, avec des visites infructueuses dans de nombreuses FOSA , sans transport adapté:

- hypothermie,
- voire au décès du nouveau-né.

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

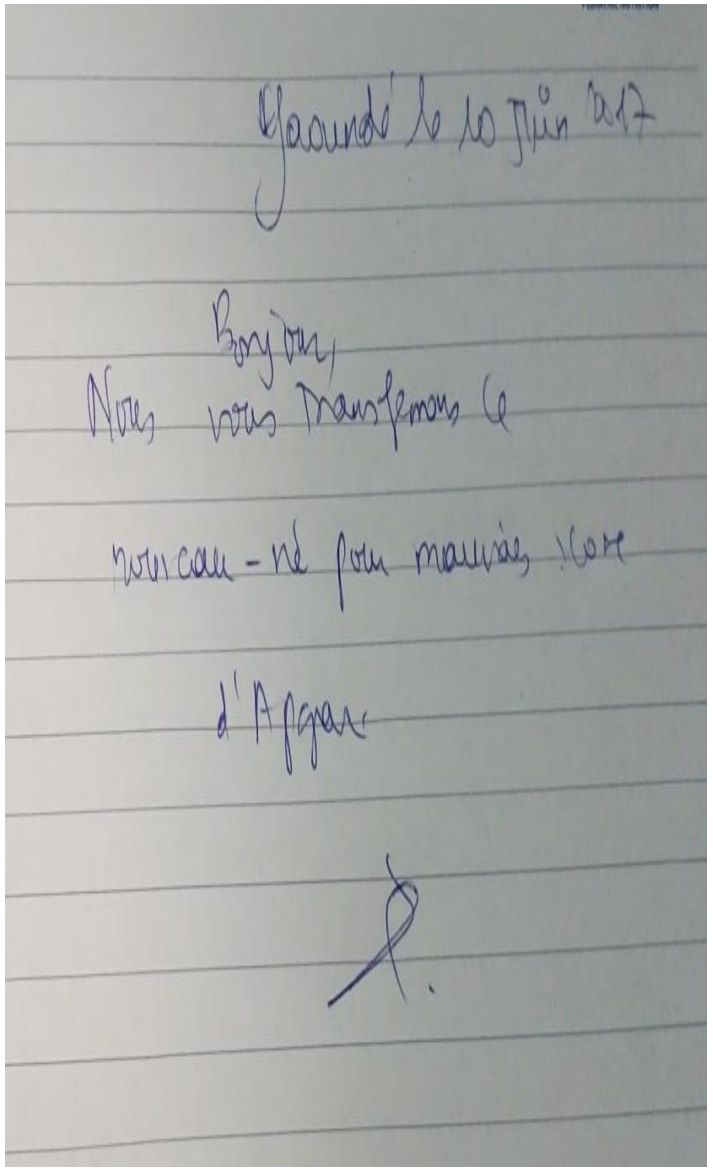
- FOSA d'accueil surpris par ce nouveau-né non attendu,

- Nouveau-né non reçu (absence de place) ,

- FOSA travaillent en vase clos: faible collaboration interhospitalière ,

- Téléphonie inter et intra hospitalière presque inexistante, peu fonctionnelle,

- Fiche de référence: quasi inexistant ou peu rempli , renseignements pauvres: CPN ? Accouchement ? PN ? allaitement ?médicaments administrés?
Problèmes du nouveau-né? ….)


Yaoundé le 10 Juin 2017

Bonjour,
Nous vous transférons ce
nouveau-né pour mauvais score
d'Apgar.

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Quelques faits saillants de références désastreuses

Cas 1 : 13 mars 2016: une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant une femme, âgée de 31 ans, enceinte de jumeaux, couchée sur le parvis de l'hôpital Laquintinie de Douala, ventre ouvert au scalpel par une autre femme pour en extirper deux fœtus

Mise en cause du personnel de santé de la FOSA accusé de négligence, d'inhumanité, de cupidité

Des proches expliquent à la télévision avoir agi pour sauver les deux enfants qui bougeaient encore dans le ventre de leur mère face à un personnel médical inactif

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Cas 2 : décès des quintuplés à la maternité de l'Hôpital Central de Yaoundé responsable d'un tollé général

Cas 3 : vol d'un nouveau-né dans une FOSA de 2ème catégorie à Yaoundé

Cas 4: nouveau-né prématuré référé dans une FOSA de 1ère catégorie sur une moto en temps de pluie

Après l'indignation des autorités / populations

Pas de solutions tangibles

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Le transfert/transport du nouveau: cause non négligeable à la mortalité néonatale au Cameroun.

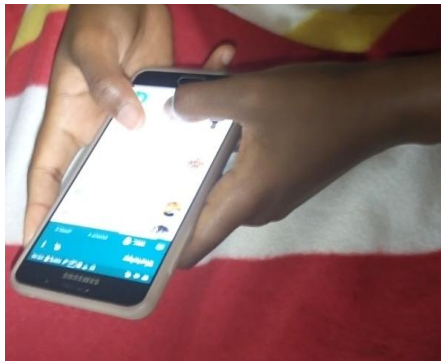
Observations empiriques et quotidiennes: les modalités et les moyens de transferts des NNS(du domicile pour les FOSA ou des FOSA vers des structures de références) souvent non sécurisés pour les nouveau-nés.

Conséquences fatales allant jusqu'à la mort de ces derniers

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

- ✓Création d'un groupe WhatsApp par les professionnels de la santé maternelle et néonatale en 2016 pour faire face à tous ces drames

- ✓Plateforme WhatsApp couramment utilisé par les prestataires de soins au Cameroun,



- ✓réseau crée de notre propre initiative ,

- ✓Avec ces réseaux, de moins en moins, l'on assiste aux spectacles désolants où les parents étaient envoyés chercher les couveuses (Moluh, 2017).

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Objectif principal :

Coordonner la référence / transfert des nouveau-nés au sein des FOSA

Objectifs spécifiques:

- Partager les disponibilités en matière d'espace et de services pour les nouveau-nés dans leur hôpital (couveuse , photothérapie…)
- Répertorier les FOSA qui disposent de l’oxygène
- Remplir la fiche de référence (cause de la référence , modalités de transport , médicaments administrés etc)
- Préférer le transfert in-utéro vers des FOSA supérieurs
- Partager les résultats des nouveau-nés orientés via le groupe WhatsApp , créant ainsi une méthode informelle de retour d'informations.
- partager les meilleures pratiques et protocoles de soins néonatals.

FICHE DE REFERENCE PERINATALITE

FICHE DE REFERENCE IN UTERO N°___

District de santé de:----------Structure sanitaire:----------

Lieu de référence_____ date et heure de référence_____

Initiales de nom + prénom entier de la parturiente_____Date et heure d'admission_____

Age gestationnel_____

Poids _____TA_____

Date d'arrivée_____

Diagnostic_____

Traitement reçu_____

_____

Motifs de référence/Signes de danger_____

_____

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Fonctionnement du réseau:

- Disponibilité d’espace et des services écrites tous les jours par les prestataires de santé
- En cas de besoin de référence ,demande écrite par PS
- Réponse par les autres PS du groupe ayant l’espace ou pas
- Orientation du nouveau-né et de sa famille vers la FOSA réceptive en fonction des moyens, car de nombreux établissements exigent un paiement direct.

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Gouvernance du réseau :

- Règlement intérieur(objectifs, fonctionnement du réseau ,et les interdits)
- Si règlement intérieur non respecté: avertissement et parfois sanction(exclusion du groupe)
- Enrôlé si règlement intérieur approuvé ,membres ajoutés au fur et mesure
- Pas de lourdeur administrative

IIIII-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Financement:

- Pas de financement direct , PS utilisent leur propre connexion internet
- 500 Poches kangourou distribués aux FOSA du RPY (dotation UNICEF)
- 3 extracteurs en oxygène au CME / FCB service néonat et soins intensifs (OMS) ,
- Appui OMS/ UNICEF aux FOSA dans la région avec des matériaux et intrants pour soins nnés en contexte Covid-19
- Explication des coûts de soins/ cautions des FOSA du RPY par PS aux familles
- Aide au choix et au lieux de référence en fonction des moyens financiers des familles

Communication:

- Outcomes des NNES partagés à travers RPY,forme de contre-référence non conventionnelle
- Partage de bonnes pratiques de soins aux NNES, partage protocoles de soins nnés
- Information sur la disponibilité des produits sanguines / groupe banque de sang
- Aide à améliorer la documentation, renseignements sur les FMC SOCAPED
- Discussion des cas des nouveau-nés pour soutenir l’engagement des prestataires dans le réseau

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Rapport de confiance

- Connaissance mutuelle : développement des rapports de confiance
- Connexions entre les prestataires qui ne se connaissent pas
- Avant les prestataires avaient peur d'être critiqués en cas de référence, mais le réseau les a réorienté aux intérêts des nouveau-nés
- Prestataires sont beaucoup moins stressés car maintenant ils savent comment orienter les cas

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

Quelques résultats

RPY : 337 membres :

cliniciens de 32 hôpitaux

et structures de soins de santé primaires,

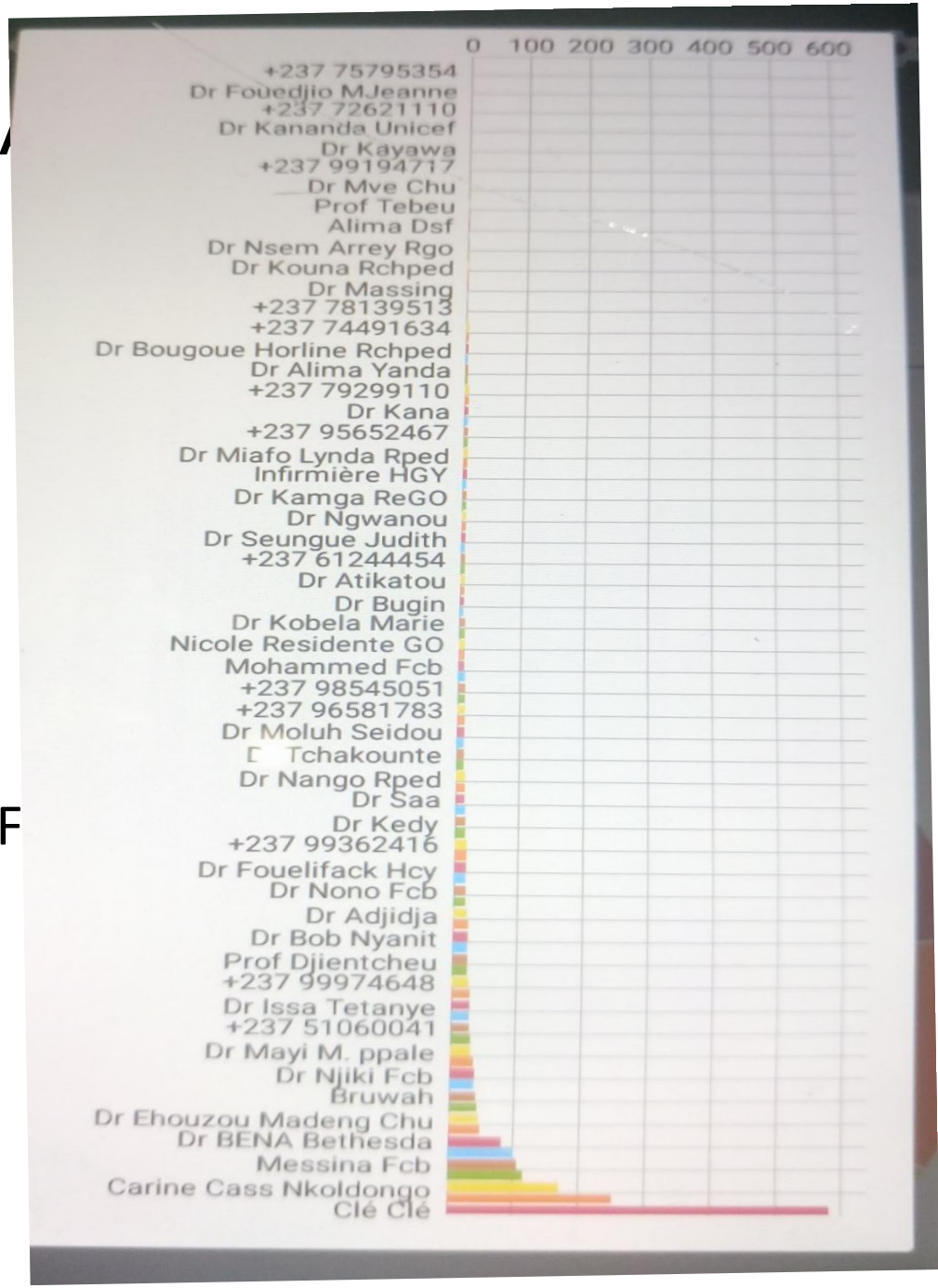
dont la moitié sont des établissements publics,

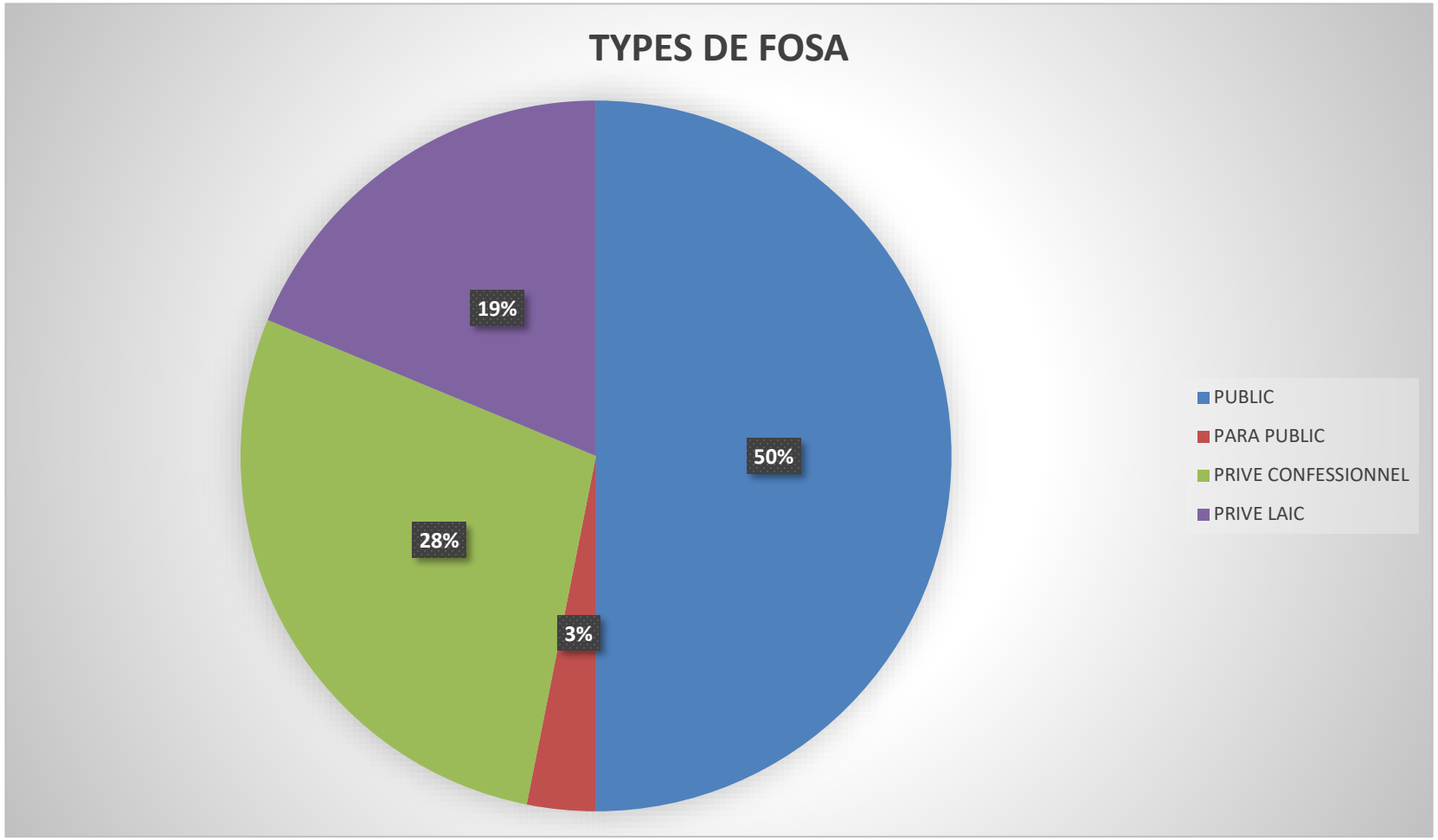
répartis dans 8 districts,

de représentants du ministère de la Santé Publique,

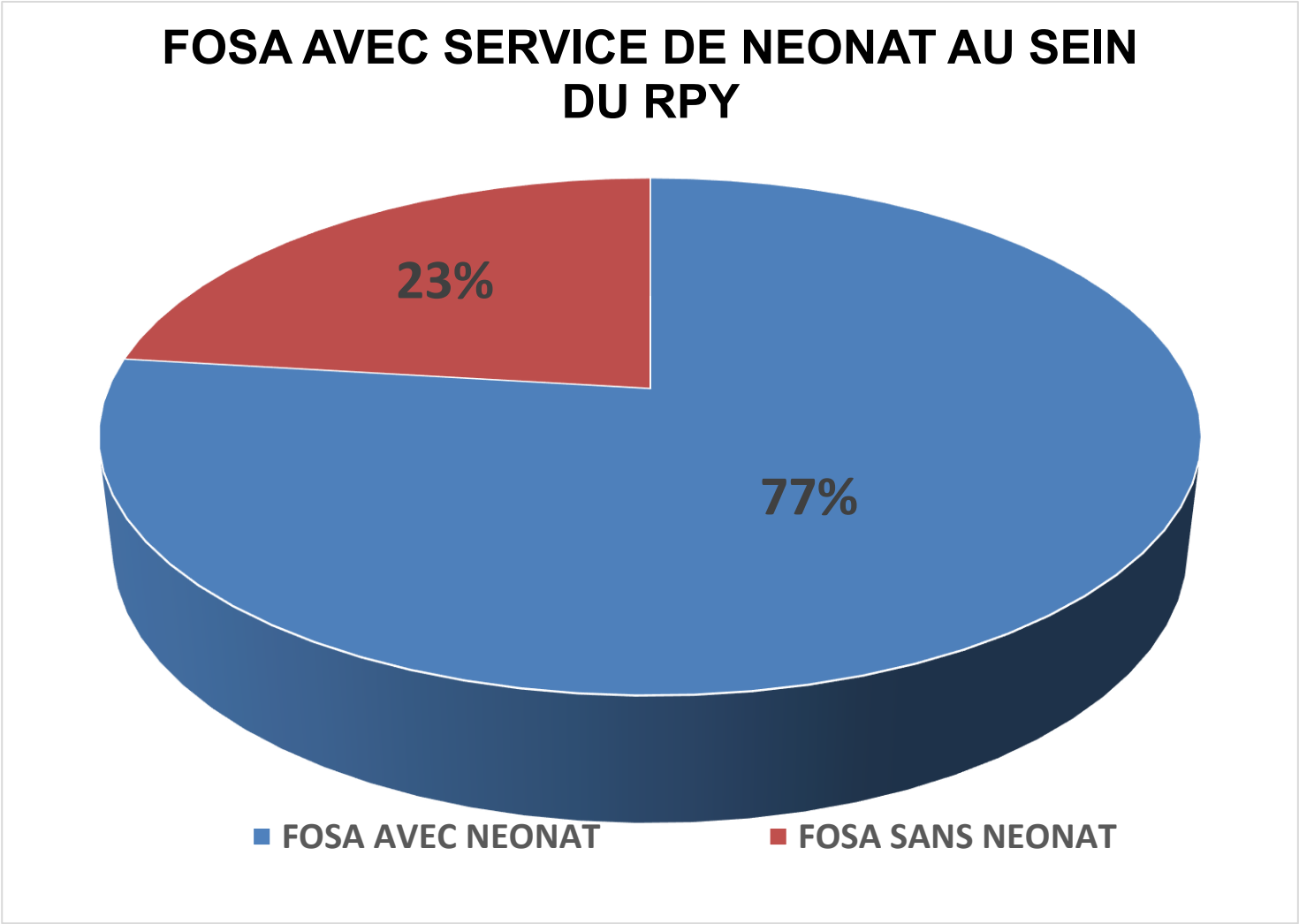
de partenaires techniques et financiers (OMS,UNICEF

d'associations professionnelles(SOCAPED, SOGOC …)



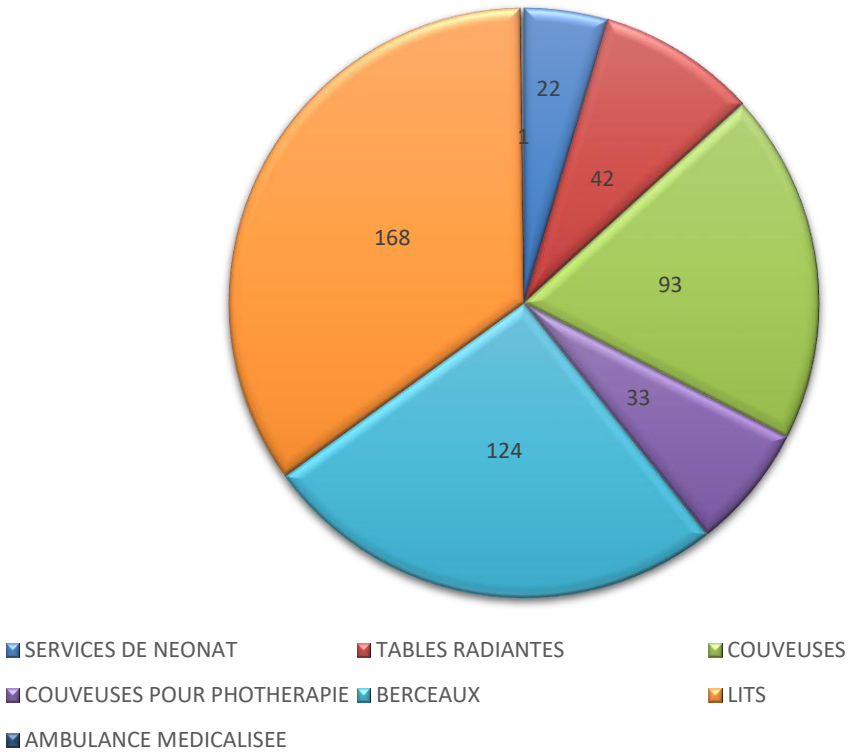


FOSA publiques les plus représentées (16 FOSA) 50%
FOSA privées confessionnelles
FOSA privées Laïc



SUR LES 32 FOSA DU RPY, 22 (77%) DISPOSENT D'UN SERVICE DE NEONAT

Espaces et Services de soins pour les nouveau-nés



- **22 sur 32 FOSA (77%) avec service de Neonat**
- **42 Tables radiantes**
- **93 couveuses**
- **33 couveuses pour photothérapie**
- **124 berceaux**
- **168 lits dont 39 au CME**
- **01 ambulance médicalisée**

CONDITIONS D' ACCES DANS LES SERVICES DE NEONAT DES FOSA DU RPY

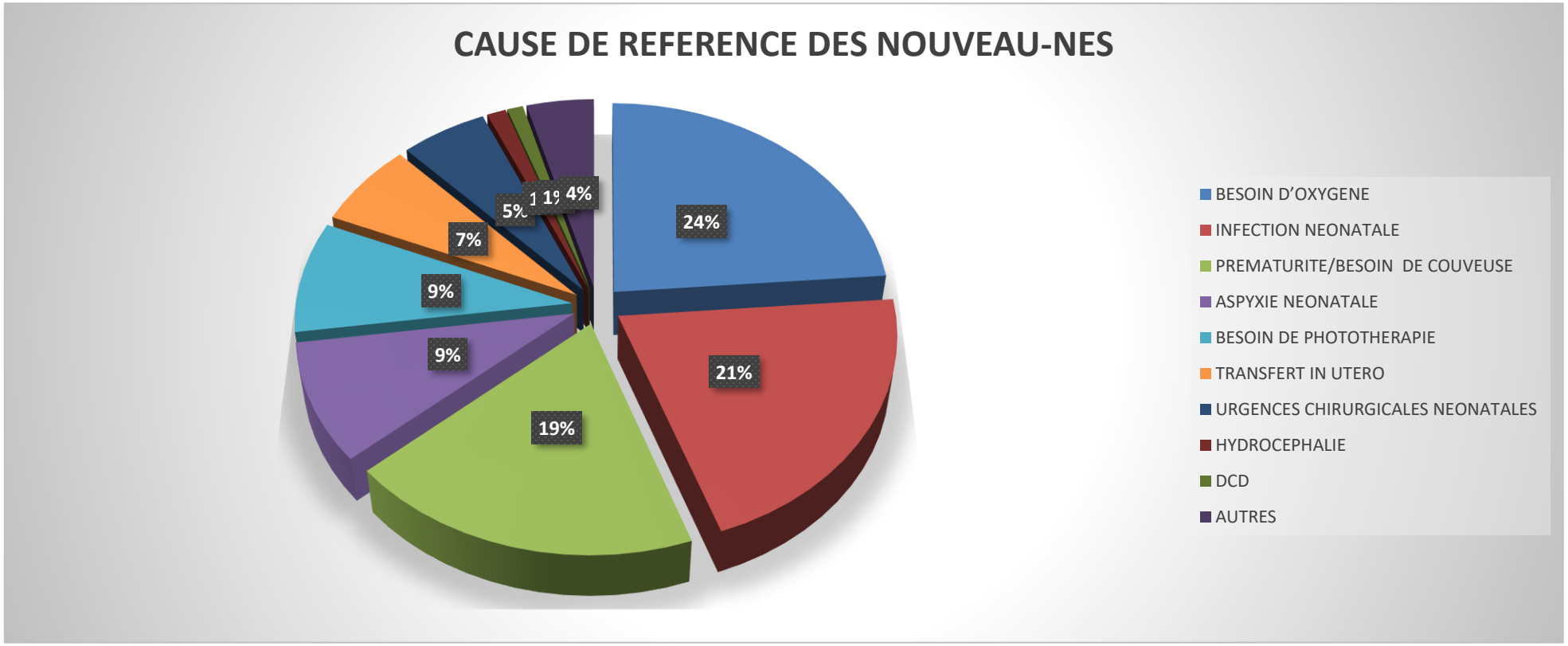
DISTRICT DE SANTE	Nom de la FOSA	Montant de la CAUTION
DS CITE VERTE	HDCV	0 PUBLIC
	MTE PPALE /HCY	0 PUBLIC
	CHRIRUGIE PED/HCY	0 PUBLIC
	CME/FCB	O PUBLIC
	CMPY(police)	PUBLIC APPARENTE
	HOPITAL BETHESDA	50 000 FCA PRIVE CONF
	CS CATHO/ BRIQUETERIE	PAS DE NEONAT PRIVE CONF
	HOPITAL DEO GRACIAS	50000 FCFA PRIVE CONF
	HDCV	PAS DE NEONAT
DS BIYEM ASSI	CHU	
	CENTRE HOSP ST MARTIN PORRES	PAS DE NEONAT
	HD BA	0 PUBLIC

CONDITIONS D' ACCES DANS LES SERVICES DE NEONAT DES FOSA DU RPY

DISTRICT DE SANTE	NOM DE LA FOSA	MONTANT DE LA CAUTION
DS DJOUNGOLO	CHE/CNPS	100 000FCFA PARAPUBLIC
	HGOPY	50 000 FCFA PUBLIC
	HGY	PAS DE NEONAT PUBLIC
	CASS DE NKOLDONGO	PAS DE NEONAT PRIVE CONF
	CHRACERH	PAS DE NEONAT PUBLIC
	HOPE SERVICE	50 000 FCFA PRIVE LAIC
DS EFOULAN	HDEF	35 000 FCFA PUBLIC
	HOP MILITAIRE	PAS DE NEONAT
	MARIA ROSA NSISIM	50 000 FCFA PRIVE LAIC
	MARIE WYSS	50 000 FCFA PRIVE LAIC
DS NKOLDONGO	NICOLAS BARRE	30 000 FCF /JR POUR L'O2
DS BAFIA	HD BAFIA	35 000 FCA PUBLIC
DS MFOU	REAVEN	50 000 FCFA PRIVE CONF

LA PLUPART DES FOSA PRIVE , PARAPUBLIQUE EXIGENT LE PAYEMENT D'UNE CAUTION A L'ENTREE

LES CAUSES DE REFERENCE DES NOUVEAU- NES MALADES avant la pandémie à Covid -19



Principaux motifs de transfert avant Covid-19 : besoin d'oxygène +++, infections néonatales , prématurité , asphyxie.

Le délai moyen de réponse aux demandes : variant de 10 à 120 secondes.

II-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE

- ✓Malgré des ressources limitées, le réseau a résolu un problème majeur d'orientation des nouveau-nés vers les services d'urgence urbains.
- ✓Cette approche simple a contribué à améliorer l'accès aux soins.
- ✓Elle a permis d'établir des relations de confiance entre les prestataires, clés de son succès, et a favorisé un changement de culture professionnelle
- ✓les prestataires craignaient d'être critiqués pour une orientation, mais le réseau a permis de recentrer l'attention sur le nouveau-né.
- ✓Facilite la communication,

III-LE RESEAU PERINAT DE YAOUNDE ET DE DOUALA

- ✓ Réduit le stress des prestataires, car ils savent désormais orienter les cas,
- ✓ Le forum facilite la collaboration, améliore la capacité des professionnels de santé à prodiguer des soins aux nouveau-nés,
- ✓ Favorise la discussion clinique des cas,
- ✓ Les prestataires des établissements isolés sont mis en relation avec d'autres prestataires et établissements, ce qui renforce la confiance et la satisfaction,
- ✓ Favorise l'amélioration des relations entre les prestataires et les personnes qui s'occupent des nouveau-nés.

Tout cela a été réalisé sans financement spécifique

Evaluation du réseau périnatal camerounais de Yaoundé, selon les éléments du réseau de soins pour la santé maternelle et néonatale

Réseaux d'éléments de soins	Clairement présent	Peut-être
Optimise les liens ainsi que la coordination et la gouvernance délibérées de la prestation de services pour fournir des soins complets de santé maternelle et néonatale (SMN) depuis la communauté jusqu'au niveau de référence.	X	
Aborde les aspects relationnels et fonctionnels de la prestation de soins continus de haute qualité	X	
Comprend les connexions formelles et informelles, la collaboration et les rapports entre et à travers les niveaux, y compris les soins primaires et spécialisés	X	

réseau de soins : une approche pour améliorer la santé maternelle et néonatale
Katherine kalaris, Emma Radovich , Clémence Vougmo ,Martina Baye

Evaluation du réseau périnatal camerounais de Yaoundé, selon les éléments du réseau de soins pour la santé maternelle et néonatale

Réseaux d'éléments de soins	Clairement présent	Peut-être
Favorise le travail d'équipe respectueux et la communication entre tous les prestataires de soins de santé à différents niveaux	X	
S'engage dans les transports, la communication (téléphone portable ou radio) et d'autres secteurs qui soutiennent les soins	X	
Intègre des mécanismes de responsabilisation conjointe des agents de santé avec les individus et les communautés et pour répondre à l'évolution des besoins en matière de soins	X	
Favorise un accès équitable aux soins, notamment en réduisant les obstacles financiers		
Mesure et surveille les processus et les résultats de santé des femmes et des nouveau-nés		

III-PERSPECTIVES

Grace aux Réseaux Périnats de Yaounde et de Douala

- Outil de plaidoyer afin que les pouvoirs publics se penchent davantage sur le sort des nouveau-nés

- Vulgarisation des Soins Maternels Kangourou(SMK) dans les grandes villes et surtout dans l'arrière pays

- Secteur privé s' est également penché sur la santé du nouveau-né avec les achats de couveuses et l'ouverture des services de néonatologie

III-PERSPECTIVES

- La redevabilité a fait en sorte que même les populations n’acceptent plus que leurs bébés meurent (manque de plateau technique, manque de couveuses, négligence etc.)

- Prise de conscience de la santé du nouveau-né (qui ne peut se défendre) dans les zones urbaines et rurales

IV-CONCLUSION

- La leçon apprise : avec de la volonté et malgré des ressources limitées , il est possible de faire bouger les lignes

- Avec un simple téléphone androïde et l'application WhasttApp , les professionnels de santé arrivent à s'organiser pour apporter des solutions tangibles aux problèmes du nouveau-né

- Il existe au Cameroun plusieurs autres réseaux qui s'occupent de la santé de la mère et du nouveau-né (réseaux de soins AGH qui englobent 2 DS)

IV-CONCLUSION

- Actuellement nous sommes en campagne électorale les questions de santé de la mère et du nouveau-né doivent s'inviter aux différents débats politiques

- Quel est le candidat qui propose quelque chose pour la santé du couple mère – nouveau-né ?

- Ceci peut faire la différence dans nos pays d'Afrique Sub-Saharienne qui porte le lourd fardeau de la mortalité maternelle et néonatale

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION